CRFMG



INFORME TÉCNICO
001/26

CIM
UNIFAL-MG

EPILEPSIA: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, ETIOLÓGICOS AVANÇOS TERAPÊUTICOS COM FOCO DO ATIVO CENOBAMATO

CRFMG

INFORME TÉCNICO

AUTORES

Organização geral e concepção

MARIA EDUARDA MAGALHÃES
MAYARA VITÓRIA SALES DE FREITAS
KAUANY GARCIA
KATIA MICHELLE FREITAS
LUCIENE ALVES MOREIRA MARQUES

CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS (CIM)
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)

E-mail: cimunifal@gmail.com
Instagram:@cim.unifal
Facebook: Cim Unifal-MG
Site: www.unifal-mg.edu.br/cim
Telefone: (35) 99136-0717
Dra. Luciene Alves Moreira Marques
Dr. Ricardo Radighieri Rascado

CRFMG

INFORME TÉCNICO

REVISORES

Equipe de Assessoria Técnica e Científica do CRFMG

DÉBORA CAROLINA LACORTE SILVA

MARIA FERNANDA DE SOUSA GOMES

WALTOVÂNIO CORDEIRO DE VASCONCELOS

ASSESSORIA TÉCNICA

31 | 3218-1012 ou 3218-1042 duvidastecnicas@crfmg.org.br

CRFMG

001/2026

EPILEPSIA: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, ETIOLÓGICOS AVANÇOS TERAPÊUTICOS COM FOCO DO ATIVO CENOBAMATO

1. INTRODUÇÃO

A epilepsia é uma das condições neurológicas mais antigas da história da medicina, caracterizando-se como uma doença crônica definida pela ocorrência de pelo menos duas crises convulsivas não provocadas (ou reflexas) ocorrendo com intervalo superior a 24 horas. (Hauser e Kurland, 1975; ILAE, 2014), resultantes de descargas elétricas paroxísticas no cérebro. Apesar dos avanços no conhecimento científico e nas abordagens terapêuticas, a epilepsia permanece como uma das doenças neurológicas mais prevalentes no mundo, afetando indivíduos de todas as faixas etárias e representando um importante problema de saúde pública.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas (OMS, 2024) convivam com a doença globalmente, com maior impacto em países de baixa e média renda devido ao acesso limitado à saúde e à maior exposição a fatores de risco.

Além das manifestações clínicas, a epilepsia implica em relevantes consequências sociais e psicológicas, frequentemente associada a comorbidades como ansiedade e depressão, além do estigma social que pode levar à subnotificação de casos.

2. FISIOPATOLOGIA E ETIOLOGIA

A fisiopatologia da epilepsia reside no desequilíbrio entre os processos de excitação neuronal (glutamato) e inibição (GABA). Durante uma crise, ocorre uma hiperexcitabilidade neuronal conhecida como "tempestade elétrica cerebral", que pode ser focal ou generalizada. Processos como inflamação, morte neuronal e alterações na barreira hematoencefálica também contribuem para a manutenção da epileptogênese.

Segundo a ILAE (2025), a etiologia da epilepsia é classificada em seis categorias:

- **Estrutural:** Anormalidades estruturais visíveis em neuroimagem que podem ser adquiridas em decorrência de AVC, trauma ou encefalopatia hipóxico-isquêmica;
- **Genética:** Decorrente de defeitos genéticos conhecidos ou presumidos, cujas crises epiléticas são o sintoma principal da doença;
- **Infecciosa:** Infecções no Sistema Nervoso Central, como tuberculose, neurocisticercose, HIV, toxoplasmose ou meningite bacteriana.
- **Metabólica:** Resulta diretamente de desequilíbrios metabólicos, como distúrbios mitocondriais, peroxissomais, deficiência de folato cerebral, distúrbios da creatina, dentre outros distúrbios relacionados à migração neuronal.
- **Imunológica:** etiologias mediadas por anticorpos como Encefalite anti-receptor NMDA, anticorpo contra receptor GABA-B ou AMPA, com suspeita em casos de

inflamação autoimune mediada no SNC, correspondendo a cerca de 5-7% dos casos.

- **Desconhecida:** Casos onde não é possível determinar a causa.

3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO

A epilepsia pode ser classificada, de acordo com o início e extensão da propagação das crises, em dois tipos principais: crises generalizadas e focais (Li et al., 2024). As crises generalizadas afetam todo o cérebro e podem causar perda de consciência (ex: crises tônico-clônicas ou de ausência), enquanto as focais iniciam em áreas específicas e podem causar alterações motoras, sensoriais ou cognitivas. O diagnóstico fundamenta-se na ocorrência de pelo menos duas crises não provocadas, apoiando-se na história clínica, eletroencefalograma (EEG), ressonância magnética e, se necessário, análise do líquido cefalorraquidiano.

4. ABORDAGENS TERAPÊUTICAS

O objetivo do tratamento é permitir uma vida irrestrita ao paciente, controlando as crises e tratando questões psicossociais. Atualmente, a epilepsia não possui cura, mas pode ser gerenciada por:

- **Tratamento Farmacológico:** Uso de fármacos antiepilépticos para inibir e prevenir o início ou a propagação da atividade convulsiva.

- **Neuromodulação:** Técnicas de aplicação de impulsos elétricos, como o estimulador do nervo vago (VNS) e estimulação cerebral profunda (DBS), indicadas para casos refratários ou quando a cirurgia não é viável ou falha, associadas à melhora na qualidade de vida e redução da mortalidade.

4.1 O PAPEL DO ATIVO CENOBAMATO (XCOPRI®)

O ativo cenobamato, um antiepiléptico de terceira geração do tipo carbamato, indicado para tratamento de diferentes tipos de epilepsia farmacorresistente, representa um avanço relevante para pacientes adultos com crises de início focal, cujas crises não foram adequadamente controladas apesar de um histórico de tratamento com pelo menos dois fármacos antiepilépticos (Arenas-Cabrera et al., 2024). Sua administração é oral e seu diferencial reside em seu mecanismo de ação dual e sinérgico:

1. **Modulação dos canais de sódio voltagem-dependente:** Estabiliza os canais em estado inativo, reduzindo a hiperexcitabilidade neuronal.

2. **Potencialização dos receptores GABA:** Aumenta a neurotransmissão inibitória, ajudando a restaurar o equilíbrio cerebral.

Evidências indicam que este fármaco promove uma redução significativa na frequência das crises, consolidando-se como uma alternativa inovadora para a terapêutica neurológica contemporânea.

5. EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA

A análise da eficácia clínica do cenobamato baseia-se em um robusto estudo multicêntrico, controlado por placebo e conduzido em regime duplo-cego em mais de 100 centros especializados ao redor do mundo. A investigação focou em pacientes

adultos (18 a 65 anos) que apresentavam um quadro de crises focais persistentes, mesmo sob terapia com até três outros fármacos antiepilépticos.

Durante o ensaio, os participantes foram randomizados para receber doses diárias de 100 mg, 200 mg ou 400 mg (uma vez ao dia) do cenobamato como fármaco adjuvante, passando por uma fase inicial após o período basal com os outros antiepilépticos s, e de ajuste de dose (titulação) seguida por um período de manutenção de 6 ou 12 semanas. O desfecho primário avaliou a mudança percentual na frequência das crises e a taxa de resposta (redução de 50% na carga de crises) em comparação ao grupo controle (KRAUSS *et al.,* 2020; ROSHNI *et al.*, 2024).

Os dados indicaram uma superioridade estatística do cenobamato frente ao placebo. Enquanto o grupo placebo registrou uma redução de 24% na frequência de crises, os pacientes tratados com o fármaco alcançaram reduções de 35,5 % (na dose de 100 mg), 55% (na dose de 200 mg) e 56% (na dose de 400 mg) (ROSHHINI *et al*., 2024).

Um diferencial clínico de grande relevância observado neste estudo foi a taxa de ausência de crises (seizure-freedom): cerca de 21% dos pacientes que utilizaram a dose máxima não registraram crises durante a fase de manutenção (KRAUSS *et al.*, 2020; ROSHNI *et al.*, 2024).

Conforme Brigo e Lattanzi (2024), observou-se elevada proporção de participantes com ausência de crises durante a fase de manutenção, com aumento da probabilidade desse desfecho associado ao uso de cenobamato, exceto na dose de 100 mg.

6. SEGURANÇA, EFEITOS ADVERSOS E INTERAÇÕES

O fármaco foi aprovado pela FDA (*Food and Drug Administratio*n, EUA) em novembro de 2019 como terapia adjuvante para crises epilépticas focais em adultos, sendo posteriormente aprovado pela EMA (Agência Europeia de Medicamentos) em março de 2021 e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, Brasil) em 9 de março deste ano (Resolução nº 855/2026) como nome comercial Xcopri® (cenobamato) da empresa Eurofarma Laboratórios S.A. Até o momento, não há aprovação para uso em pacientes pediátricos.

O Xcopri® (cenobamato) exige vigilância rigorosa quanto à sua segurança, iniciando pelo risco de reações de hipersensibilidade graves, como a síndrome DRESS (Reação a Medicamentos com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos). Esta condição, potencialmente fatal, afeta múltiplos órgãos e pode se manifestar por febre, erupções cutâneas e inflamação dos gânglios linfáticos. Além dos riscos de reações alérgicas graves, o perfil de segurança do Xcopri® exige atenção especial à saúde cardiovascular e hepática, sendo contraindicado para pacientes com síndrome do QT curto familiar, uma vez que o fármaco pode causar o encurtamento do intervalo QT no eletrocardiograma. Antes de iniciar e durante o tratamento, recomenda-se a realização de exames laboratoriais para monitoramento da função hepática, sendo que pacientes com comprometimento hepático moderado não devem exceder a dose diária de 200 mg. O medicamento também exerce efeitos significativos no sistema nervoso central, sendo frequentes eventos adversos como sonolência extrema, tontura, fadiga, visão dupla e cefaleia. Devido a esses efeitos sedativos, orienta-se evitar o consumo de álcool e adotar cautela ao dirigir veículos até que se conheça a resposta individual do tratamento (DRUGS.COM, 2026; SK LIFE SCIENCE, 2026; WILLIAMSON, 2025).

No contexto das interações e dos aspectos de saúde mental, o Xcopri pode alterar a eficácia de fármacos concomitantes, incluindo anticoncepcionais hormonais, além de interagir com outros antiepilépticos como a fenitoína e o clobazam, o que pode demandar ajustes individualizados de dose. Em adição, há um alerta para o risco de ideação ou comportamentos suicidas, efeito observado em diversas drogas antiepilépticas, o que torna essencial o monitoramento contínuo de alterações de humor ou comportamento durante o tratamento. Por fim, ressalta-se que a descontinuação não deve ocorrer de forma abrupta, pois a interrupção súbita pode desencadear crises graves e prolongadas, conhecidas como estado de mal epilético. Assim, reforça-se a importância de uma comunicação contínua e efetiva entre o paciente e o profissional de saúde (DRUGS.COM, 2026; SK LIFE SCIENCE, 2026; WILLIAMSON, 2025).

7. POSOLOGIA

O Xcopri® (cenobamato) é um medicamento de administração oral, em dose única diária, indicado para o tratamento de crises epiléticas de início focal em pacientes adultos, podendo ser ingerido independentemente da alimentação, de forma íntegra ou após a trituração. A eficácia terapêutica e a segurança do tratamento estão condicionadas à adoção de um esquema de titulação gradual, iniciando com uma dose de 12,5 mg seguida de aumentos graduais em intervalos de duas semanas até o alcance da dose de manutenção, geralmente situada entre 100 mg e 400 mg por dia. Esse escalonamento lento é essencial para mitigação do risco de reações adversas graves, particularmente as de hipersensibilidade sistêmica,como a síndrome DRESS (DRUGS.COM, 2026; SK LIFE SCIENCE, 2026).

8. PAPEL DO FARMACÊUTICO

O farmacêutico desempenha um papel crucial no manejo da epilepsia, sua atuação inicia-se na dispensação qualificada e consolida-se no acompanhamento farmacoterapêutico, o qual é essencial para garantir o alcance dos objetivos clínicos.

A adesão ao tratamento é o pilar fundamental, pois a epilepsia exige alta adesão para que os medicamentos antiepilépticos (AEDs) funcionem efetivamente. Estudos demonstram o impacto positivo da atuação do farmacêutico no manejo da epilepsia com redução significativa da frequência e a gravidade das crises epilépticas. Ademais, a intervenção farmacêutica contribui para o aprimoramento do conhecimento dos pacientes, prevenção de problemas relacionados aos medicamentos, bem como para a melhora da adesão ao tratamento e da qualidade de vida (Chen et al., 2013; Lertsinudom et al., 2014; Eshiet et al., 2022).

A interrupção da terapia constitui um dos principais riscos no manejo da epilepsia, estando diretamente associada à recorrência das crises, ao aumento da ocorrência de lesões e à mortalidade prematura. Além disso, o monitoramento de efeitos adversos é essencial, uma vez que diversos fármacos antiepilépticos podem estar relacionados ao desenvolvimento de depressão, ansiedade e redução da qualidade de vida, fatores que frequentemente contribuem para a não adesão ou abandono do tratamento.

A orientação sobre interações medicamentosas é indispensável, particularmente para os 20% a 30% de pacientes que necessitam de terapia combinada. Nesse contexto, o farmacêutico atua no manejo de associações recomendadas, visando o sinergismo terapêutico e a redução da toxicidade. Além disso, supervisiona o uso de abordagens complementares, como a dieta cetogênica ou tratamentos fitoterápicos (ex: *Cicuta virosa* e *Nux vomica*), assegurando que tais intervenções não interfiram

negativamente nos alvos moleculares dos medicamentos convencionais (GHOSH, S. et al,2021).

9. COMPARAÇÃO COM ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS

O tratamento da epilepsia busca o controle total das crises com o mínimo de efeitos adversos, visando a qualidade de vida do paciente. Devido a isso, o Ministério da Saúde fez um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia, que foi aprovado pela Portaria Conjunta nº 17, de 21 de junho de 2018.

De acordo com o protocolo, a carbamazepina é amplamente utilizada como primeira escolha para crises de início focal, atuando no bloqueio de canais de sódio, sendo um potente indutor da maioria das isoenzimas do citocromo P-450 .Evidências sugerem que a carbamazepina é melhor tolerada com a formulação de liberação controlada (Beydoun et al., 2020).Embora eficaz, a utilização requer monitoramento de níveis séricos devido à sua estreita janela terapêutica . O valproato, por sua vez, possui um amplo espectro de ação, sendo a primeira linha para crises generalizadas. Contudo, seu uso é limitado em mulheres em idade fértil devido ao alto risco de teratogenicidade

Como alternativa, as diretrizes destacam a lamotrigina por ser melhor tolerada, especialmente em idosos, e por possuir menor risco de malformações fetais em comparação ao valproato. Já o levetiracetam é valorizado por seu perfil farmacocinético favorável, apresentando poucas interações medicamentosas e início de ação rápido, sendo indicado como terapia adjuvante em casos refratários.

10. ASPECTOS REGULATÓRIOS E ACESSO

Em 9 de março de 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do fármaco, conforme publicado no Diário Oficial da União através da Resolução nº 855/2026. Apesar da aprovação regulatória, o acesso ao Xcopri não é imediato, uma vez que a comercialização no Brasil depende previamente da definição do preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Trata-se de etapa regulatória indispensável antes da disponibilização do medicamento nas farmácias.

Quanto à disponibilidade no Sistema Único de Saúde (SUS), a incorporação do cenobamato à rede pública depende de um processo específico. A eventual oferta está condicionada à avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e à decisão final do Ministério da Saúde. Nesse processo, a Conitec considera não apenas a eficácia clínica (com estudos demonstrando redução de crises em até 64% dos pacientes em uso da dose de 400 mg) mas também a relação custo-efetividade para o sistema público de saúde.

O possível elevado custo do cenobamato constitui um fator relevante no contexto de acesso ao medicamento. O Ministério da Saúde já incluiu o cenobamato em processos de dispensa de licitação para aquisições coordenadas pelo Departamento de Logística em Saúde, procedimento usualmente adotado para medicamentos de alta complexidade ou elevado valor. Para aproximadamente 30% dos pacientes com epilepsia refratária aos tratamentos disponíveis, a aprovação regulatória de 2026 representa uma perspectiva promissora, mas o acesso efetivo ainda depende da conclusão das etapas de precificação e das avaliações de incorporação tecnológica no âmbito do sistema público de saúde.

11. CONCLUSÃO

O cenobamato representa um avanço significativo no tratamento da epilepsia farmacorresistente, uma condição que afeta cerca de 30% dos pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais. Com seu mecanismo de ação duplo exclusivo, que atua na modulação de canais de sódio e na potencialização de receptores GABA, o fármaco oferece uma nova perspectiva para adultos com crises de início focal.

Evidências clínicas robustas confirmam sua eficácia, demonstrando não apenas a redução na frequência das crises, mas também taxas expressivas de ausências de crises em pacientes refratários. Entretanto, seu uso exige cautela rigorosa. A necessidade de titulação gradual é fundamental para prevenir reações adversas graves como a síndrome DRESS, além de demandar monitoramento constante de funções hepáticas e cardiovasculares.

No cenário brasileiro, a aprovação pela Anvisa em março de 2026 marca o início de uma nova etapa de manejo da doença no país. Embora o acesso efetivo ainda dependa de processos regulatórios de precificação e de avaliação pela Conitec para incorporação ao SUS, o cenobamato consolida-se como uma alternativa terapêutica promissora, associando inovação científica ao potencial de melhoria da qualidade de vida de pacientes com opções terapêuticas limitadas.

REFERÊNCIAS

BANERJEE, P. N.; FILIPPI, D.; HAUSER, W. A. **The descriptive epidemiology of epilepsy: a review.** *Epilepsy Research*, v. 85, n. 1, p. 31–45, 2009. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy. Acesso em: 22 abr. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **A Anvisa aprova novo medicamento para epilepsia**: Xcopri® pode reduzir crises em pacientes que não respondem aos tratamentos oferecidos atualmente. Brasília, DF: Anvisa, 9 mar. 2026. Disponível em: Portal gov.br. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **XCOPRI® (Cenobamato).** Brasília, DF: Anvisa, 12 mar. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/xcopri-cenobamato. Acesso em: 22 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. **Portaria Conjunta nº 17, de 21 de junho de 2018**: aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.
Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Logística em Saúde. **Dispensa de Licitação nº 526/2025 - Processo nº 25000.156372/2025-87**: aquisição de Quinidina sulfato, Maralixibato, Ácido Cólico, Cenobamato, Vamorolona, Nitisinona e Omaveloxolona. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 13 fev. 2026. Disponível em: Portal gov.br. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social (Secom). **A Anvisa aprova novo medicamento para tratar epilepsia resistente em adultos**: o cenobamato é indicado para pacientes que continuam tendo crises mesmo após dois tratamentos. Brasília, DF: Secom, 10 mar. 2026. Disponível em: Portal gov.br. Acesso em: 20 abr. 2026.

DRUGS.COM. **Xcopri: package insert / prescribing information / MOA**. Medicamente revisado por Drugs.com. 4 fev. 2026. Disponível em: https://www.drugs.com/pro/xcopri.html. Acesso em: 21 abr. 2026.

GHOSH, S. *et al.* Pharmacological and Therapeutic Approaches in the Treatment of Epilepsy. **Biomedicines**, Basileia, v. 9, n. 5, p. 470, abr. 2021,. Disponível em: https://doi.org/10.3390/biomedicines9050470. Acesso em: 20 abr. 2026.

INSTITUTE FOR QUALITY AND EFFICIENCY IN HEALTH CARE (IQWiG). **Overview: Epilepsy**. Cologne, Alemanha: IQWiG, 4 maio 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK343313/. Acesso em: 22 abr. 2026.

KRAUSS, Gregory L. *et al.* Safety and efficacy of cenobamate in adults with uncontrolled focal seizures: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 dose-response trial. **The Lancet Neurology**, v. 19, n. 1, p. 38-48, Jan. 2020. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31734103/. Acesso em: 14 abr. 2026.

ROSENOW, F. et al. Current role of carbamazepine and oxcarbazepine in the management of epilepsy. **Seizure: European Journal of Epilepsy**, v. 78, p. 31–37, 2020. Disponível em: https://www.seizure-journal.com/article/S1059-1311(20)30336-8/fulltext. Acesso em: 26 abr. 2026.

ROSHNI, S. D.; FERREIRA, A. B.; MANKAD, K. **Cenobamate**. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, jan. 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK600010/. Acesso em: 21 abr. 2026.

SK LIFE SCIENCE. **Taking XCOPRI: dosage and side effects**. Paramus: SK Life Science, Inc., 2026. Disponível em: https://www.xcopri.com/taking-xcopri/. Acesso em: 21 abr. 2026.

VERA-GONZÁLEZ, Alejandro. Pathophysiological Mechanisms Underlying the Etiologies of Seizures and Epilepsy. In: CZUCZWAR, S. J. (ed.). **Epilepsy**. Brisbane, Austrália: Exon Publications, 2 abr. 2022. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK580618/. Acesso em: 22 abr. 2026.

WILLIAMSON, Jennifer Mitri. **Xcopri side effects and how to manage them**. Medicamente revisado por Stan Saji. Medical News Today, 25 set. 2025. Disponível em: https://www.medicalnewstoday.com/articles/drugs-xcopri-side-effects. Acesso em: 21 abr. 2026.